

OCCLUSIÓN INTESTINAL

Oliva López I. Alcoba García L.M.

INTRODUCCIÓN

La oclusión u obstrucción intestinal se produce cuando se interrumpe el flujo normal de contenido intraluminal, es decir, existe una ausencia de tránsito intestinal para gases y heces de forma persistente en el tiempo. Puede afectar al intestino delgado o al colon produciendo una dilatación proximal. En el caso de no ser completa ni persistente se utilizaría el término de **Suboclusión intestinal**.

Según su localización puede ser:

- Oclusión de intestino delgado.
- Oclusión de colon.

PATOGENIA

- Íleo paralítico (funcional): alteración de la motilidad intestinal sin causa obstructiva.
- Íleo mecánico (oclusión mecánica): se produce por la existencia de un obstáculo, intrínseco o extrínseco, que impide el tránsito intestinal. Puede ser aguda o crónica.

La oclusión mecánica se define como estrangulada cuando existe compromiso vascular del segmento intestinal afecto pudiendo provocar necrosis o perforación.

El término **pseudoobstrucción intestinal idiopática o Síndrome de Ogilvie** se refiere a una enfermedad producida por alteraciones en los plexos intramurales o en el músculo liso intestinal, con cuadros recurrentes de obstrucción intestinal sin causa mecánica objetivable. En muchos casos precisa endoscopia diagnóstica y descompresiva.

ETIOLOGÍA

- En pacientes con antecedentes de cirugía abdominal la causa más frecuente son las adherencias y bridas postoperatorias.
- En pacientes no intervenidos previamente la causa más frecuente son las hernias de la pared abdominal e inguinales. En frecuencia le siguen las neoplasias colorrectales.

ÍLEO PARALÍTICO	Neurógeno Alteración electrolítica Alteración vascular Infecciones	Postoperatorio de cirugía abdominal, distensión ureteral, pancreatitis, peritonitis, lesión medular. Hipopotasemia. Isquemia intestinal. Neumonías, septicemias.
ÍLEO MECÁNICO	Obstrucción de la luz intestinal: cuerpos extraños, bezoares, fecaloma. Lesiones intrínsecas: Diverticulitis, enfermedad de Crohn, neoplasias, lesiones congénitas estenosantes. Masas extraintestinales: abscesos, quistes, tumores. Bridas o adherencias (congénitas, inflamatorias, neoplásicas, postquirúrgicas). Hernias y vólvulos.	

ÍLEO PARALÍTICO

Diagnóstico

Clínica

- Presencia de dolor abdominal no cólico de intensidad leve. En ocasiones hay ausencia de dolor.
- Distensión abdominal.
- Estreñimiento. Pueden aparecer vómitos.
- Clínica del proceso que causa el íleo, aunque suele ser larvada y no destaca por encima de la clínica digestiva (neumonía basal, pancreatitis, cólico renal...)

Exploración Física:

- Distensión abdominal y timpanismo.
- Palpación: dolor abdominal difuso sin signos de peritonismo.
- Tacto rectal normal.

Pruebas Complementarias

- Laboratorio: hemograma y bioquímica con función renal e iones.
- Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral): Descartar la presencia de una neumonía basal.
- Radiografía de Abdomen simple: donde se objetivará una dilatación de intestino delgado y de todo el marco cólico con gas en ampolla rectal.

Tratamiento

- Dieta absoluta, canalización de vía periférica y reposición hidroelectrolítica con suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día), sonda nasogástrica y enemas de limpieza para estimular el tránsito intestinal.
- El propio de la causa subyacente.

ÍLEO MECÁNICO

Diagnóstico

Clínica

- Dolor abdominal tipo cólico. Se vuelve continuo cuando existe compromiso vascular.
- Distensión abdominal.
- Vómitos biliosos si la obstrucción es alta (intestino delgado) o fecaloideos si es baja (obstrucción de colon).
- Ausencia de tránsito para heces y gases. No es un signo constante, en ocasiones existen deposiciones líquidas (diarrea por rebosamiento) o evacuación de heces distales.

- Diferenciar si la válvula ileocecal es competente en la obstrucción de colon. Si es incompetente observaremos dilatación de colon y de intestino delgado con clínica de distensión y vómitos, precisando de colocación de sonda nasogástrica. Si es competente no existirá dilatación de intestino delgado existiendo mayor riesgo de perforación diastásica e isquémica de ciego.

Exploración Física:

Se debe inspeccionar el abdomen en busca de cicatrices quirúrgicas o hernias.

- Alteración electrolítica y mal estado general por presencia de tercer espacio y vómitos.
 - Distensión abdominal y timpanismo.
 - Valorar palpando los posibles orificios herniarios: umbilical, epigástrico, Spiegel, inguinal, crural, y descartar masas abdominales.
 - Dolor difuso con irritación peritoneal si existe compromiso vascular o complicación de la obstrucción.
 - En el tacto rectal podemos objetivar fecaloma o tumor rectal en la oclusión baja de colon.
- En pacientes aóneas con clínica de estreñimiento y oclusión de intestino delgado pensar en la hernia crural que, por su alto riesgo de compromiso vascular, no se debe intentar reducir y es indicación de intervención quirúrgica urgente.

Pruebas Complementarias

- Laboratorio: hemograma (hemoconcentración por pérdida de líquidos, anemia por pérdidas sanguíneas en neoplasias de colon, leucocitosis por peritonitis) y bioquímica con función renal e iones (hipopotasemia, insuficiencia renal por deshidratación).
- Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral): Descartar la presencia de una neumonía basal y posible neumoperitoneo (indica la existencia de perforación de víscera hueca).
- Radiografía de abdomen simple: En la oclusión de intestino delgado objetivaremos la dilatación de las válvulas conniventes, imagen típica en “pilas de monedas”, con niveles hidroaéreos en la radiografía
- en bipedestación. En la oclusión de colon con válvula incompetente se observan las haustras del colon y las “pilas de monedas” del delgado; mientras que si es competente sólo se observa dilatación de colon.
- Si la causa obstructiva es un vólvulo de colon se observa la típica imagen en “grano de café”.
 - Aerobilia: Descartar la posibilidad de un íleo biliar.
 - La ecografía no es una buena prueba de imagen en pacientes con oclusión intestinal ya que el aire intraluminal no permite una correcta evaluación.
 - TC abdominal: en la mayoría de los casos se precisa para llegar al diagnóstico final y localización de la obstrucción.



Tratamiento

- Dieta absoluta. Canalización de vía periférica y reposición hidroelectrolítica con suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día).
- Sonda nasogástrica en el caso de dilatación de intestino delgado.
- Antibioterapia ante la sospecha de obstrucción estrangulada (Cefuroxima 750 mg/8 horas, Piperacilina-tazobactam (Tazocel®) 4/0,5 g/8 horas, Ertapenem (Invanz ®) 1g/24 horas, Metronidazol (Flagyl®) 500 mg/8 horas, asociarlo cuando se sospecha infección por organismos anaerobios).

Tratamiento específico

- Vólvulo de sigma: puede tratarse con sonda rectal o precisar la realización de una colonoscopia.
- Fecaloma: fragmentación y extracción del mismo. Enemas de limpieza.
- Hernias inguinales: si no hay signos de compromiso vascular se puede intentar la reducción y programar una cirugía preferente; si existen datos de posible compromiso vascular o presencia de una hernia crural, está contraindicada la reducción y la actitud debe ser una cirugía urgente.
- Ante una oclusión por neoplasia de colon se puede intentar la colocación de una guía y endoprótesis trastumoral previo a cirugía diferida o bien, cuando no es posible, cirugía derivativa.
- Síndrome adherencial: observación y tratamiento conservador durante 48-72 horas. Si no se resuelve, valorar intervención quirúrgica.
- Sospecha de compromiso vascular: consulta a cirugía general para intervención quirúrgica urgente.

BIBLIOGRAFIA

- Markogiannakis H, Messaris E, Dardamanis D, et al. Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome. World J Gastroenterol 2007; 13:432.
- Diaz JJ Jr, Bokhari F, Mowery NT, et al. Guidelines for management of small bowel obstruction. J Trauma 2008; 64:1651.
- Catena F, Di Saverio S, Kelly MD, et al. Bologna Guidelines for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO): 2010 Evidence-Based Guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg 2011; 6:5.